Critérios Diagnósticos e Tratamento

AC1 — 7º Período de Medicina · Resumo das 15 Doenças

1. ASMA

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

- Espirometria com obstrução reversível: ↑VEF1 ≥ 12% **e** ≥ 200 mL pós-BD
- Variabilidade do PFE > 10% (adultos)
- Teste de broncoprovocação positivo (metacolina) se espirometria normal
- Classificação de controle GINA: sintomas diurnos, despertares noturnos, limitação de atividade, uso de resgate

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

- **GINA Via 1 (preferencial)**: ICS-formoterol sob demanda em todos os Steps
- **Step 1–2**: ICS-formoterol dose baixa sob demanda (budesonida-formoterol 200/6 µg)
- **Step 3**: ICS-formoterol dose baixa como manutenção + resgate (MART)
- **Step 4**: ICS-formoterol dose média como manutenção + resgate
- **Step 5**: encaminhar; adicionar LAMA (tiotrópio) ou anti-IgE/anti-IL5
- **SABA isolado NÃO é mais recomendado** em nenhum step
- **LABA isolado é CONTRAINDICADO** (↑mortalidade sem ICS)

2. DPOC

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

- Espirometria pós-BD: VEF1/CVF < 0,7 (obstrução fixa, não reversível)
- Classificação GOLD por VEF1: 1 (≥80%), 2 (50–79%), 3 (30–49%), 4 (<30%)
- Grupos ABE: A (pouco sintoma, sem exacerbações), B (sintomático), E (exacerbador ≥2/ano ou ≥1 com internação)

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

- **Grupo A**: broncodilatador de curta (SABA ou SAMA) conforme necessidade
- **Grupo B**: LABA + LAMA de manutenção
- **Grupo E**: LABA + LAMA; adicionar ICS se eosinófilos ≥ 300
- **Exacerbação**: BD de curta ação + prednisona 40 mg VO 5 dias + ATB se escarro purulento
- **VNI**: 1ª escolha se acidose respiratória hipercápnica (pH <7,35, pCO2↑)
- **ICS isolado NÃO tem papel na DPOC**

3. DRGE (Doença do Refluxo Gastroesofágico)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

- **Lyon 2.0** — Evidência conclusiva: EDA com esofagite LA grau B–D, Barrett longo, estenose péptica
- pHmetria: AET > 6% e/ou exposição ácida noturna > 2% são conclusivos
- AET 4–6% = zona inconclusiva (avaliar nº episódios, MNBI <1500Ω)
- LA-A pode ser inespecífica — não confirma DRGE isoladamente

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

- **IBP dose plena 1x/dia**: omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg ou esomeprazol 40 mg
- Duração: 4–8 semanas; se refratário → IBP dose dobrada (2x/dia)
- **Medidas comportamentais**: elevar cabeceira, evitar deitar 2–3h pós-refeição, perda de peso
- **Cirurgia antirrefluxo**: se refratário com DRGE comprovada objetivamente

4. DUP (Doença Ulcerosa Péptica)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

- EDA: exame definitivo (localização, Forrest, biópsia se gástrica)
- Pesquisa de H. pylori obrigatória (urease, histologia, antígeno fecal ou teste respiratório)
- Forrest: IA/IB/IIA = alto risco → hemostasia endoscópica; III = baixo risco

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

- **H. pylori +**: IBP dose dobrada + amoxicilina 1 g 2x/dia + claritromicina 500 mg 2x/dia por **14 dias**
- **Associada a AINEs**: IBP 1x/dia por 4–8 semanas + suspender AINE
- **Idiopática**: IBP 1x/dia por 4–8 semanas
- **Complicada (sangramento)**: IBP dose alta 80 mg bolus + 8 mg/h IV por 72h
- **Estenose pilórica**: IBP dose alta + dilatação endoscópica por balão

5. Esofagite Eosinofílica (EoE)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

- 3 critérios obrigatórios (ACG 2025):
- 1) Sintomas de disfunção esofágica (disfagia, impactação alimentar)
- 2) ≥ 15 eosinófilos/CGA na biópsia esofágica
- 3) Exclusão de outras causas de eosinofilia esofágica
- Monitoramento: IMPACT (sintomas) + EREFS (endoscopia)

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

- **IBP dose alta 2x/dia**: omeprazol 40 mg 2x/dia ou equivalente (1ª linha)
- **Budesonida orodispersível**: 2 mg 2x/dia (corticoide tópico deglutido)
- **Budesonida tópica**: 1 mg 2x/dia (preparo viscoso)
- **Dupilumabe**: 300 mg SC semanal (anti-IL4/IL13 — biológico aprovado)
- **Dieta de eliminação**: 2, 4 ou 6 alimentos com reintrodução sequencial
- Dilatação endoscópica se estenose (trata consequência, não inflamação)

6. DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

- **RegiSCAR score**: febre, linfadenopatia, eosinofilia, linfócitos atípicos, exantema ≥50% SC, biópsia, envolvimento de órgão, duração ≥15 dias
- Score: <2 exclui; 2–3 possível; 4–5 provável; ≥6 definitivo
- Latência típica: 2–8 semanas (diferença-chave vs SSJ/NET: 10–14 dias)
- Fármacos clássicos: alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos, sulfonamidas

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

- **Universal**: retirar fármaco culpado imediatamente; proscrever classe inteira
- **Leve**: corticoide tópico alta potência (clobetasol 0,05% 2–3x/dia)
- **Grave**: prednisona 0,5–1 mg/kg/dia VO, desmame lento em **8–12 semanas**
- NÃO usar pulsoterapia (OR 4,7 para mortalidade)
- **Refratário**: ciclosporina 3–5 mg/kg/dia VO 2x/dia por 7 dias (CI se DRC)
- IGIV NÃO recomendada; antiviral (ganciclovir) só se PCR alta + dano de órgão viral

7. Febre Reumática Aguda (FRA)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• **Critérios de Jones 2015 (AHA)**: 1º episódio = 2 maiores OU 1 maior + 2 menores + evidência strep
• Maiores (alto risco/Brasil): cardite, poliartrite/monoartrite/poliartralgia, coreia de Sydenham, eritema marginado, nódulos subcutâneos
• Menores: febre ≥38°C, ↑VHS/PCR, PR prolongado, poliartralgia (se artrite não for maior)
• Exceção: coreia de Sydenham isolada + evidência strep = suficiente para diagnóstico

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Erradicação strep**: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM dose única
■ **Profilaxia 2ª**: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM a cada 21 dias
■ Duração: sem cardite = 5a/21a; com cardite s/ sequela = 10a/21a; com sequela valvar = 10a/40a
■ **Artrite**: naproxeno 10–20 mg/kg/dia ou AAS 80–100 mg/kg/dia
■ **Cardite**: prednisona 1–2 mg/kg/dia
■ **Coreia de Sydenham**: valproato de sódio

---

8. HPTP (Hiperparatireoidismo Primário)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• Ca sérico elevado + PTH inapropriadamente elevado (não suprimido)
• HPTP normocalcêmico: Ca normal + PTH persistentemente elevado (excluir causas 2ªs)
• **Critérios cirúrgicos**: Ca >1 mg/dL acima do LSN, T-score ≤ –2,5, TFG <60 mL/min, calciúria >250–300 mg/dia, idade <50 anos, fratura por fragilidade

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Cirurgia (paratireoidectomia)**: tratamento definitivo se preenche critérios
■ **Cinacalcete**: calcimimético — reduz PTH e calcemia via CaSR (se não opera)
■ **Alendronato ou denosumabe**: se osteoporose associada
■ **Vitamina D**: repor se 25OHD <30 ng/mL
■ Monitoramento: Ca, Cr, DMO anuais se observação clínica

---

9. Insuficiência Cardíaca (IC)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• Sintomas/sinais de IC + anormalidade estrutural/funcional cardíaca
• Peptídeos natriuréticos — exclusão: BNP <100 (agudo), <35 (crônico); NT-proBNP <300/<125
• FEVE: ICFEr ≤40% | ICFEi 41–49% | ICFEp ≥50%
• Etiologia: mnemônico CHAMPIT (Coronária, HAS, valvopatia, Miocardiopatia, Pericárdio, Infecção, Toxinas)
• Em obesos e/ou uso de ARNI: preferir NT-proBNP (BNP sofre clearance por NPR-C e é degradado pela neprilisina)

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Terapia quádrupla ICFEr** (iniciar todos precocemente, titular):
■ 1) **ARNI**: sacubitril-valsartana 49/51 → 97/103 mg 2x/dia (washout 36h do IECA)
■ 2) **BB**: carvedilol 3,125→25 mg 2x/dia; metoprolol succ. 12,5→200 mg 1x/dia; bisoprolol 1,25→10 mg 1x/dia
■ 3) **ARM**: espironolactona 25–50 mg 1x/dia
■ 4) **iSGLT2**: dapagliflozina 10 mg ou empagliflozina 10 mg 1x/dia
■ NÃO suspender mesmo com FEVE recuperada (TRED-HF: 44% recidiva)

---

10. IRA (Injúria Renal Aguda)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• **KDIGO**: Estágio 1 — Cr ≥0,3 mg/dL em 48h ou 1,5–1,9× basal; Estágio 2 — 2–2,9×; Estágio 3 — ≥3× ou Cr ≥4 ou necessidade de TRS
• Diálise de urgência (AEIOU): Acidose refratária, Eletrólitos (K■ refratário c/ ECG), Intoxicação, Overload (hipervolemia), Uremia sintomática
• Triple whammy: IECA + BRA + AINE → colapso da TFG em hipovolemia

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **SHR-AKI (hepatorrenal)**: terlipressina 0,5–1 mg IV 4–6/6h + albumina 20–40 g/dia
■ **Leptospirose**: penicilina cristalina 1,5 milhão UI IV 6/6h
■ **Rabdomiólise**: expansão volêmica agressiva 200–300 mL/h de SF 0,9%
■ **Hipercalemia aguda**: gluconato de Ca 10% IV + insulina + glicose + salbutamol NB
■ **Indicações de diálise**: hipercalemia/acidose/hipervolemia refratárias a medidas clínicas

---

11. Litíase Renal

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• História clínica + bioquímica sérica/urinária + imagem (TC sem contraste = padrão-ouro) + análise de composição do cálculo
• Tipos: cálcio-oxalato (mais comum), ácido úrico, estruvita (infeccioso), cistina
• Estruvita: bactérias produtoras de urease (Proteus) → pH >7 → cristalização

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Universal**: hidratação ≥ 2,5 L/dia para todos os tipos
■ **Ca-oxalato hipercalciúrico**: tiazídico — HCTZ 25–50 mg, clortalidona 25 mg ou indapamida 2,5 mg
■ **Ca-oxalato hipocitratúrico**: citrato de potássio
■ **Ca-oxalato hiperuricosúrico**: alopurinol 100–300 mg/dia
■ **Ácido úrico**: citrato de potássio (alvo pH 6,5–7,0) — pode dissolver cálculos existentes
■ **Cistina**: hidratação ≥ 4 L/dia + citrato K (pH 7,0); se insuficiente → tiopronina
■ **Estruvita**: remoção cirúrgica completa + erradicação da infecção

---

12. Nefrite Intersticial Aguda (NIA)

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• IRA + piúria estéril + relação temporal com fármaco novo (semanas)
• Tríade clássica (rash + febre + eosinofilia) presente em **<10%** dos casos
• AINEs: exceção — NIA **sem** eosinofilia, pode ter síndrome nefrótica (lesão mínima)
• Biópsia (padrão-ouro): edema intersticial + infiltrado linfócitos T + tubulite
• NIA por ICI (anti-PD-1): infiltrado linfoplasmocitário, sem eosinofilia

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Sempre**: retirar fármaco suspeito; proscrever classe inteira
■ Sem melhora em 3–7 dias → biópsia + **prednisona 1 mg/kg/dia** (60–80 mg) VO
■ Se diálise iminente → **metilprednisolona 500–1000 mg IV** por 3 dias
■ Desmame: 2 sem dose plena → reduzir 10 mg a cada 3–5 dias → lento após 10 mg (total 4–12 sem)
■ **Refratário**: micofenolato de mofetila 1–2 g/dia VO
■ NIA por AINE: geralmente NÃO responde a corticoide
■ NIA por ICI: suspender ICI + prednisona 1 mg/kg/dia (tratamento ativo necessário)

---

13. Tétano

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• **Diagnóstico CLÍNICO**: trismo, rigidez cervical/abdominal, espasmos generalizados, riso sardônico
• Não há exame laboratorial confirmatório
• Ferimento de risco + esquema vacinal incompleto (<3 doses) → profilaxia com IGHAT

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **1. Imunoglobulina**: IGHAT 3.000–6.000 UI IM (terapêutico) ou 500 UI (profilaxia); SAT 20.000–30.000 UI se indisponível
■ **2. Debridamento cirúrgico**: 1–6h após imunoglobulina
■ **3. Antibiótico**: metronidazol 500 mg IV 8/8h (1ª escolha; penicilina pode ↑espasmos)
■ **4. Espasmos**: diazepam 1–10 mg/kg/dia IV ± baclofeno ou midazolam
■ **5. Disautonomia**: MgSO■ 40 mg/kg bolus + 2 g/h por 7 dias; opioides; α2-agonistas. **EVITAR BB puros**
■ **6. Via aérea**: traqueostomia precoce (24h) — preferida sobre IOT (evita espasmos de glote)
■ Vacina dT: administrar durante internação (tétano NÃO confere imunidade)

---

14. Hipertensão Arterial — Diagnóstico e Tratamento Crônico

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• PA consultório ≥ 140/90 mmHg (em 2 ocasiões ou MAPA/MRPA)
• MAPA: vigília ≥ 135/85; 24h ≥ 130/80; sono ≥ 120/70
• Fenótipos: HA sustentada, avental branco (consultório alta, MAPA normal), mascarada (consultório normal, MAPA alta)
• Meta geral: < 130/80 mmHg
• HA resistente: PA ≥ 130/80 com 3 classes incluindo diurético; HA refratária: ≥ 5 classes incluindo ARM

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Início**: combinação dupla (tiazídico + IECA/BRA ou BCC) — NÃO monoterapia
■ **Tiazídicos**: HCTZ 12,5–25 mg, clortalidona 12,5–25 mg, indapamida 1,5–2,5 mg
■ **IECA**: enalapril 5–40 mg, ramipril 2,5–10 mg, perindopril 4–8 mg
■ **BRA**: losartana 25–100 mg, valsartana 80–320 mg, telmisartana 40–80 mg
■ **BCC**: anlodipino 2,5–10 mg, nifedipino retard 20–60 mg
■ **4º fármaco (HAR)**: espironolactona 12,5–50 mg (PATHWAY-2)
■ **5º–6º**: BB (carvedilol, nebivolol), clonidina 0,1–0,3 mg 2–3x/dia, doxazosina 1–16 mg
■ Nunca associar IECA + BRA (ONTARGET: hipercalemia + IRA, sem benefício)

---

15. Hipertensão Arterial — Crise Hipertensiva

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

• **Emergência**: PA elevada COM lesão aguda de órgão-alvo → UTI, fármaco IV
• **Urgência / Elevação importante**: PA elevada SEM lesão de órgão-alvo → VO, redução em 24–48h
• **Pseudocrise**: PA elevada secundária a dor/ansiedade → tratar a causa

TRATAMENTO — PRINCIPAIS MEDICAÇÕES

■ **Meta geral**: reduzir 20–25% na 1ª hora; 160/100–110 em 2–6h
■ **Nitroprussiato**: 0,25–10 µg/kg/min IV (todos os cenários exceto gestação)
■ **Nitroglicerina**: 5–200 µg/min IV (SCA, EAP)
■ **Metoprolol IV**: 5 mg a cada 5 min (máx 15 mg); **Esmolol**: 500 µg/kg bolus + 25–50 µg/kg/min
■ **Hidralazina IV**: 5–10 mg (gestação — 1ª escolha; CI em dissecção/SCA)
■ **Furosemida**: 20–60 mg IV (APENAS se congestão)
■ **Dissecção de aorta**: meta PAS 100–120 e FC <60 em 20 min. **BB PRIMEIRO** (esmolol/metoprolol), depois vasodilatador
■ **Eclâmpsia**: hidralazina IV + MgSO■ (anticonvulsivante). IECA/BRA CONTRAINDICADOS na gestação
■ **AVC isquêmico s/ trombólise**: hipertensão permissiva — tratar só se >220/120